

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS	
ANTONIA DIAS DA SILVA	
IDADE: 74	PESO: 71,2 ALTURA: 1,58
PROFISSÃO: Secretária Postura	
SINTOMAS: Perda memória, 1	
QUEIXAS:	
MEDICAMENTOS: Qicasida / Qefage / AAS / Sertralina / fomin / Curcaterina	
MÉDICO: Dr. Carlos Lacerda (Neurologista)	
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N	
EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates / Fisioterapia	
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 19:30	
HORA QUE DORME: 23h	HORA QUE ACORDA: 6h
COCHILLO () SIM (X) NÃO	DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO (X) EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO	
FUMO () SIM () NÃO / DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 20 anos	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal	BANHEIRO: 2x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não	MALLAMPATI:
IAH: 37,9 e/h	SPO2: 91% mínimo
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / Diabetes / artrose / microlesões cerebrais (AVC?)	
CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA	
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS	
07/08/24 Avaliação	
13/08/24 Consulta On line	
P = 4-10 cmH ₂ O / ↓ P = 5-8 cmH ₂ O	
IAH = 3,5 e/h	
m de uso: 5h 21'	
Fuga P ₉₅ : 35,4 l/m	
Boca Relata abertura de boca	
Orienta exc. língua no cu da boca.	
Natacha	
19/08/24 P = 4,8 cmH ₂ O	
IAH = 3,0	
m. de uso = 4h 24'	
Fuga = 20,2	
Bem adaptada, q tosse seca a noite.	
prox. on-line	
Jua.	
03/09/24 P = 5-8 cmH ₂ O / Percentil: 7,8 cmH ₂ O	
IAH = 8,6 e/h / 6,5 e/h (dispendido)	
m de uso: 3h 43'	
Fuga: 26,5 l/m	
Relata apresentar tosse alérgica por uma dificuldade em usar mais tempo.	
Orienta uso da máscara Correto	
Natacha	

16/09/24 P=7,8 cmH₂O → melhorou da tosse - tomou Antialérgico
 IAH= 3,3 e/lh → estava colocando máscara errado *hoco filtro*
 m uso= 5h23' niente e ajusto
 fuga= 39 l/min Se sente bem disposta

16/10/24 P=7,8 cmH₂O
 m. de uso: 4hrs { 1sd ↑ de 4hrs 23hrs vai dormir
 IAH= 3,6 e/lv { 1sd ↓ de 4hrs esta cl tisse
 fuga: 18.7 lpm sua
vai passar no pneumologista

21/11/2024 P=7,8 cmH₂O → fiz teste func^o pulmonar: Aguarda result
 IAH= 1,5 e/lh *hoco filtro* melhorou tosse
 m uso= 6 horas *hoquei bojo* siue
 fuga= 18 l/min

22/03/25 P=7,8 cmH₂O → Aprendeu a ir no banheiro cl a máscara
 IAH= 4,1 e/lh → Bem adaptada
 m de uso: 8h6'
 fuga: 5,4 l/m

24/03/25 P=7,8 cmH₂O Natucha
 IAH= 2,3 e/lh Bem adaptada
 m uso= 5h45 min
 fuga= 29 l/min vai de pra comprar siue



CRUZ AZUL
Saúde e Educação

Dr. CASSIO LACERDA

CRM: 178785SP - Neurologia | RQE 79166

Nome: ANTONIA DIAS DA SILVA

CPF: 280.876.608-46

1. Orientações para uso de CPAP

Paciente supracitada, 74 anos, possui diagnóstico de Apnéia Obstrutiva do Sono grave, diagnosticada em exame de polissonografia tipo I em 16/12/2023 (IAHI: 37,9 eventos/hora, SpO2 mínima: 81%).

Necessita fazer uso regular de CPAP noturno com pressão de 9cmH2O e máscara NASAL para tratamento da patologia.

Sugiro utilizar CPAP automático ou auto-ajustável no primeiro mês de tratamento, com pressão variando entre 6-12cmH2O a fim de realizar titulação de pressão terapêutica.

CID 10: G47.3

São Paulo - SP, 28 de fevereiro de 2024.

Dr. Cássio Batista Lacerda
CRM 178785-SP

CASSIO BATISTA LACERDA
Médico Neurologista
CRM/SP 178785



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code

Endereço: Av. Lins de Vasconcelos, 356

CASSIO BATISTA LACERDA - CRM 178785 SP

Token (Farmácia): RzV7D6 - Código de desbloqueio (Paciente): 7668

Data e hora: 28/02/2024 - 10:01:34 (GMT-3)

Av. Lins de Vasconcelos, 356



Divisão de Neurofisiologia Clínica Laboratório de Polissonografia - PSG

IDENTIFICAÇÃO

Exame: 23.04186
Nome: ANTONIA DIAS DA SILVA
Idade: 74 anos
Sexo: F
Data: 16/12/2023

POLISSONOGRAFIA

HISTÓRIA CLÍNICA (segundo respostas ao questionário pré-exame)

Paciente de 74 anos, sexo feminino, com sobrepeso (IMC= 29,6), referindo “acordar durante à noite e perder o sono” (sic). De acordo com o questionário modelo Johns Hopkins respondido pré-exame, refere que se deita às 23:00hs e dorme às 23:30hs; acorda e se levanta às 6:00hs. Não tem dificuldades em iniciar o sono e algumas vezes tem problemas para mantê-lo. Refere ronco que não incomoda outras pessoas. Sempre tem problemas para respirar durante a noite. Frequentemente acorda sufocada ou com falta de ar. Não para de respirar durante o sono. Sempre se levanta cansada ou com a sensação de não ter se descansado. Frequentemente faz cochilos que são reparadores. Usualmente sonha durante os cochilos. Não se esforça para ficar acordada durante o dia. Algumas vezes sente-se com sono ou sonolenta durante o dia. Não dorme mais tempo em finais de semana ou feriados. Não se sente cansada ou com sono durante o início da noite. Não tem sonhos amedrontadores ou pesadelos. Não range os dentes. Não tem sono inquieto. Refere pressão alta, pneumonia, “nódulo no pulmão” (sic), colesterol alto, diabetes, hepatite, infecção urinária, artrose e ansiedade. Faz uso de Jardiance®, Glicazida, SeloZok®, Triplixam®, Sinvastatina, Sertralina, Somalgim® e Dprev®. Foi encaminhada pelo Dr. Cássio Batista Lacerda para realização de polissonografia por provável síndrome da apneia obstrutiva do sono.

PROCEDIMENTO

O exame foi realizado em ar ambiente. O sono foi monitorado e estadiado manualmente conforme recomendação standard manual da *American Academy of Sleep Medicine* (The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events Summary of Updates in Version 2.6, 2023).

Profissional Técnico: Isabel Cristina Duvanel Yogi

PSG basal / Titulação CPAP - BiPAP - Servo / Múltiplos Testes de Latência do Sono / PSG+EEG
A Neuro-Sono é certificada pelo CREMESP sob nº 910496. Responsável Técnico: Dr. Gilmar Fernandes do Prado CRM 49.905.
CMVS: 35503080186303659615. Rua Cláudio Rossi, 394. Telefone: 11.5081.6629 / 11.94039.7143 (WhatsApp).
E-mail: neuro.sono.394@gmail.com